Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Lyan Gabriela Silva Peña			Sexo	F ☒	M ☐	
Fecha Nacimiento	19-02-2021	Edad actual	4 años	1 meses	País natal:	Chile	
Domicilio actual:	calle diputado ernesto [illegible] cortes norte 1512 (Los Andes)			Teléfono	974429950		
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende ☒ habla ☒ lee ☐ escribe ☐				
Lengua de uso	Español	Grado dominio	comprende ☒ habla ☒ lee ☐ escribe ☐				
Escolaridad actual:	PK - B	Establecimiento	Liceo Mixto básica N°2				

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 1-04-2025	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Francesca Peña	Nombre:
Relación con el/la estudiante: mamá	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista: 1-04-2025	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Gabriela Martones Alfaro	Nombre:
Rol/cargo: ED. Diferencial	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

Ingreso a Programa de Integración escolar 2025.

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☒ No ☐ Sí **(especificar)**

Pediatría: X control sano (normal)	Psicología:
Kinesiología:	Psiquiatría:
Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología:	Terapia Ocupacional:
Neurología:	Otro:

5.1. Primer año de vida		
Tipo de parto: ☒ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☐ cesárea (señalar motivo) 41+[illegible].		
Tuvo asistencia médica durante el parto? ☐ SI ☐ NO	Peso: 3,400	Talla: 49.
Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:		

Tuvo muchos problemas médicos / hospitalización por embarazo de alto riesgo (previo aborto). Hormà en maternidad para limpiar la sangre ya que poseía los 2 tipos de sangre (+ y -) el mes previo limpio la sangre. La madre tuvo depresión post parto.

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Sí	[✓ No]	Traumatismos	Sí	[✓ No]	Encefalitis	Sí	[✓ No]
Obesidad	Sí	[✓ No]	Intoxicación	Sí	[✓ No]	Meningitis	Sí	[✓ No]
Fiebre alta	[✓ Sí]	No	Enfermedad respiratoria	Sí	[✓ No]	Otra(s)		
Convulsiones	Sí	[✓ No]	Asma	Sí	[✓ No]			
Hospitalizaciones	Sí	[✓ No]	Especifique motivos y duración:					
Se realizaron controles periódicos de salud	[✓ Sí]	No		Vacunas			[✓ Sí]	No

Observaciones:
→ Otitis a los 6 meses. (comenzó con dolor y fiebre).
→ Problemas estomacales a veces hasta 3 veces al año.

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a) → ocasionalmente

Fija la cabeza: 3 m	Se sienta sólo/a: 6 m	Camina sin apoyo: 1 a, 2 m.
Primeras palabras: 8 m pa-pa	Primeras frases: 1 a, 6 m	Se viste solo/a: Ahora 4 a. 3 a y algo
Controla esfínter vesical Diurno: ______ Nocturno:______	Controla esfínter anal Diurno: _______ Nocturno:________	

Observaciones: a los 2 años dejó los pañales de día y de noche.

En su actividad motora general se aprecia:
☐ normal ☐ activo ☒ hiperactivo ☐ hipoactivo

Su tono muscular general se aprecia:
☐ normal ☐ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia: → porque es inquieta.

Estabilidad al caminar	[✓ Sí]	No	Caídas frecuentes	[✓ Sí]	No	Dominancia lateral No se.	Sí	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	[✓ Sí]	No	Prensión	[✓ Sí]	No	Pinza	[✓ Sí]	No
Ensarta	[✓ Sí]	No	Dibuja	[✓ Sí]	No	Escribe	[✓ Sí]	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	[✓ Sí]	No	Manipula y Explora objetos	[✓ Sí]	No
Demanda objetos y compañía	[✓ Sí]	No	Comprende prohibiciones	[✓ Sí]	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	[✓ Sí]	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Si	[✓ No]

Observaciones:

5.3. Visión - Audición:

Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	[✓ Sí]	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	[✓ Sí]	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	[✓ No]	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	[✓ Sí]	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	[✓ No]	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	[✓ Sí]	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño) Los acerca (la tablet).	Sí	No	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	[✓ Sí]	No
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	[✓ Sí]	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí	[✓ No]
Presénta movimientos oculares "anormales"	Sí	No	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	[✓ No]
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques) Solo porque es inquieta.	Sí	No	La pronunciación oral es adecuada	Sí	No
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	[✓ No]	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	[✓ No]

Observaciones:

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.4. Desarrollo del Lenguaje

El niño (a) se comunica preferentemente en forma

☐ oral ☐ gestual ☒ mixto ☐ otro (especifique):

Características del lenguaje expresivo

Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	[✓ Sí]	No	Emite/produce frases	[✓ Sí]	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	[✓ Sí]	No	Relata experiencias + o -	[✓ Sí]	No
Emite palabras/produce señas	[✓ Sí]	No	La emisión/pronunciación/producción es clara + o -	Sí	No

Características del lenguaje comprensivo

Identifica objetos	[✓ Sí]	No	Sigue instrucciones simples	[✓ Sí]	No
Identifica personas	[✓ Sí]	No	Sigue instrucciones complejas	Sí	[✓ No]
Comprende conceptos abstractos + o -	Sí	No	Sigue instrucciones grupales	[✓ Sí]	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria (A veces responde yo no sé.)	Sí	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos (monosílabos).	[✓ Sí]	No

Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos):

Observaciones:

5.5. Desarrollo Social

Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	[✓ Sí]	No	Se relaciona en forma colaborativa	[✓ Sí]	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	[✓ Sí]	No	Respeta normas sociales	[✓ Sí]	No
Participa en actividades grupales (Solo con hermanos)	Sí	No	Respeta normas escolares	[✓ Sí]	No
Opta por trabajo individual	Sí	[✓ No]	Muestra sentido del humor A veces	Sí	No (Tiene su genio). (Tiene un carácter fuerte)
Presenta lenguaje ecolálico	Sí	[✓ No]	Movimientos estereotipados	Sí	[✓ No]
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	Sí	[✓ No]	Pataletas frecuentes	Sí	[✓ No]

Ante los siguientes estímulos su reacción es:

Luces: ☐ natural ☐ desmesurada	**Sonidos:** ☐ natural ☐ desmesurada	**Personas extrañas:** ☐ natural ☐ desmesurada

Observaciones:

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante

Vacunas al día	[✓ Sí]	No	Trastorno motor	Sí	[✓ No]
Epilepsia	Sí	[✓ No]	Problema bronco-respiratorio	Sí	[✓ No]
Problemas cardiacos	Sí	[✓ No]	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	[✓ No]
Paraplejia	Sí	[✓ No]	Trastorno emocional	Sí	[✓ No]
Pérdida auditiva	Sí	[✓ No]	Trastorno conductual	Sí	[✓ No]
Pérdida visual	Sí	No	Otro (especifique):		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique):

▷ para lo que tiene apetito con el almuerzo a veces no quiere comer a la hora.

Alimentación: ☐ normal ☐ "malo/a" para comer ☒ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): ☒ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad

Sueño: ☐ normal ☒ tranquilo ☐ inquieto Horas que duerme: 12 Hrs y más.

☐ insomnio ☐ pesadillas ☒ terrores nocturnos (Ocasionalmente) ☐ sonambulismo ☐ despierta de buen humor

Duerme: ☐ solo ☐ acompañado (Duerme con [illegible])
(Especifique): A veces sola ha dormido en ocasiones solamente. muy seguido 2 a 3 veces a la semana.

Humor/comportamiento *(señale el comportamiento habitual)*

☑ alegre ☑ juguetón/bromista ☑ risueño(a) ☐ triste ☐ serio ☒ rebelde ☐ apático ☒ violento(a)

Otro: Ve películas. ▷ De repente No De repente depende de la situación

Observaciones:

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.

Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Rigoberto Silva	Papá	36	básica	panificador (panadero, ~~[illegible]~~ el [illegible])
2. Francisca Peña.	Mamá	31	En. media completa.	Almacén en la casa.
3. Keannoruy Silva	Hermano mayor	16.	Estudiando	
4. Yehibrian Vasquez	Hermano	14	estudiando.	
5. Dennely Olivares	Hermana	12	Estudiando.	
6. Liah.				
7.				
8.				

Antecedentes de Salud de la Familia

(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):

Yehibrian tiene autismo grado 1, muchos problemas de aprendizaje, Trastorno específico del aprendizaje.
Sobrino con autismo grado 2.
Abuela materna deficiencia mental, no puede leer ni escribir y el [illegible].

Observaciones:

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar

Edad de ingreso al sistema escolar	4a	Asistió a jardín infantil	Sí [✓ No]
Nº de colegios en que ha estudiado	1	Modalidad de enseñanza Regular ☒ Especial ☐ Técnica ☐:	

Motivo de los cambios:

Ha repetido curso/s	Sí	[✓ No]	Curso(s)	Motivo:

Situación actual

Nivel/curso actual	PK-B		**Dificultad de aprendizaje**	[✓ Sí]	No	**Dificultad para participar**	Sí	[✓ No]	**Conducta disruptiva**	Sí	[✓ No]
Asiste regularmente	[✓ Sí]	No	Asiste con agrado	[✓ Sí]	No	Apoyo familiar en tareas	[✓ Sí]	No	Amigos (as) (Hartos.)	[✓ Sí]	No

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?
☑ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) ....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?
☑ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐ compasión ☐ tensión ☐ otra ....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?
☑ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra ....

Especifique el tipo de refuerzos o premios:
☐ expresiones afectivas ☐ alimentos preferidos ☑ ver TV ☐ juguetes ☐ tiempo libre ☐ otro(s)..........

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?
☑ madre ☐ padre ☐ hermanos/as ☐ Otros familiares ☐ Otros profesionales ....

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?
☑ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?

4

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

☒ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado: